

Tocolise · trabalho de parto prematuro

Tocolise ganha tempo para corticoide e transferência — não prolonga gestação indefinidamente. Confirme TPP verdadeiro e exclua contraindicações (infecção, DPP, sofrimento).

Agentes

Dica - Agentes

Nifedipina e atosibana são opções frequentes; indometacina em janelas precoces (<32 sem) com cuidado fetal. ;"Ö vöæ—7F 2 6 × am por efeitos maternos.

Objetivo: 48 h de janela + neuroproteção com MgSO₄, se <32 sem.

TPP com tocolise

Diagnosticar -> corticoide -> tocolítico

TPP verdadeiro

dinâmica + colo

Corticoide

betametasona

Tocolise +/- Mg

48h / <32 sem

Pacote de prematuridade

- Corticosteroide antenatal para maturidade pulmonar
- MgSO₄, para neuroproteção se parto iminente <32 semanas
- ATB se RPM/GBS conforme protocolo — não 'profilaxia cega' em TPP sem RPM
- Transferir para centro com UTI neonatal

Contraindicações à tocolise

Situação | Motivo

Sofrimento fetal | Parto urgente

DPP / sangramento grave | Risco materno

Corioamnionite | Esvaziar útero

Óbito fetal / malformação letal | Sem benefício

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não some nifedipina com MgSO₄, em doses que gerem bloqueio neuromuscular/hipotensão grave sem monitoramento. Tocolise após 34–34+6 sem raramente se justifica.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1